

Perguntas encaminhadas a ACM

1. Gestão de Risco, Protocolos e Intervenção

- 1.1. Validação Clínica: Existe um psicólogo ou corpo clínico parceiro disponível para validar os critérios de triagem e risco agudo definidos pelas equipes? Qual seria o canal formal para essa validação durante o hackathon?
- 1.2. Protocolo de Crise: Em caso de detecção de risco agudo (suicídio ou surto), qual é o protocolo de escalonamento esperado pela ACM? A solução deve apenas sinalizar para uma equipe humana específica ou integrar-se a algum serviço de emergência existente?
- 1.3. Triagem Inicial (Checklist nº 1): Quais são as métricas ou sinais vitais/clínicos prioritários que devem constar obrigatoriamente no primeiro filtro de risco?
- 1.4. Modelo de Apoio entre Pares: Para casos de risco moderado, a conexão "peer-to-peer" deve ser feita aleatoriamente entre usuários cadastrados ou há uma camada de curadoria/especialistas que valida esses pares antes da conexão?

2. Dados, Indicadores e Personas

- 2.1. Dashboard de Gestão: Quais KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) ou dados agregados/anônimos são prioritários para a ACM acompanhar no dashboard administrativo? (Ex: taxa de adesão, picos de estresse por especialidade, tempo médio de resposta).
- 2.2. Perfil do Usuário: Há disponibilidade de dados demográficos ou perfis típicos dos profissionais de saúde atendidos pela ACM para auxiliar na definição precisa das personas?
- 2.3. Jornada do Usuário: É possível acessar relatos anonimizados ou estudos de caso sobre a "jornada do sofrimento" desses profissionais? O objetivo é entender as barreiras emocionais e culturais que impedem a busca por ajuda.

3. Histórico de Iniciativas (Lições Aprendidas)

- 3.1. Análise de Falhas: Quais iniciativas anteriores (internas ou externas) tentaram abordar este problema na região e não obtiveram o sucesso esperado? Quais foram as principais barreiras identificadas pela ACM (ex: estigma, falta de tempo, usabilidade)?
- 3.2. Cases de Sucesso: Existem iniciativas benchmark, seja na ACM ou em outras regiões, que tenham mostrado resultados positivos? Quais fatores críticos de sucesso podem ser replicados no contexto catarinense?

4. Escopo Técnico da Prova de Conceito (PoC)

4.1. Abrangência dos Formulários: A documentação menciona quatro formulários distintos de avaliação. Para a PoC do Hackathon, a expectativa é que desenvolvamos o fluxo completo dos quatro ou devemos focar na profundidade e eficácia de apenas um deles (ex: o de triagem inicial)?

Respostas Recebidas

Prezadas equipes,

Agradeço a consolidação organizada das dúvidas. Seguem os esclarecimentos:

1. Gestão de Risco, Protocolos e Intervenção

1.1. Validação Clínica: os critérios de triagem e risco agudo definidos pelas equipes podem ser validados com o meu apoio (Dr. Marcello Alberton). O canal formal para essa validação durante o hackathon é o encaminhamento por e-mail para a ACM.

1.2. Protocolo de Crise: em caso de gravidade detectada (risco agudo, idealização suicida ou surto), a solução deve realizar a devida comunicação para os canais de serviços de emergência já existentes, com direcionamento diferenciado conforme o vínculo do profissional — rede SUS ou plano de saúde/rede privada. Não é esperada integração técnica direta com esses serviços nesta fase; o essencial é o direcionamento correto e imediato.

1.3. Triagem Inicial: recomendamos o uso do GAD-2 e do PHQ-2 como primeiro filtro — dois questionários validados, de apenas duas perguntas cada, para rastreio de ansiedade e depressão, respectivamente. São instrumentos curtos, de baixo atrito e amplamente validados na literatura, adequados para o momento de entrada do usuário. Em caso de positivos (pontuação maior igual a 3) abrem os questionários ampliados: Gad 7 e PHQ9 para uma triagem mais aprofundada, para melhor direcionamento.

1.4. Apoio entre Pares: para risco leve e moderado, a expectativa é uma comunicação específica com canais de apoio — serviços de psicoterapia disponíveis via SUS, rede privada e programas empresariais. A curadoria dos especialistas para essa conexão poderá ser feita também por mim Dr. Marcello Alberton neste momento inicial

2. Dados, Indicadores e Personas

2.1. Dashboard de Gestão: os KPIs prioritários para esta fase são, essencialmente, o número de questionários respondidos e a taxa de resposta da pesquisa de seguimento (follow-up) — ou seja, o quanto conseguimos acompanhar como o profissional está após a interação inicial e o encaminhamento.

2.2. Perfil do Usuário: nesta fase, não há disponibilidade de dados demográficos ou perfis típicos consolidados para uso das equipes.

2.3. Jornada do Usuário: ainda não temos essa informação estruturada — o serviço em si ainda não existe. O que a ACM tem claro é o reconhecimento da dor desses profissionais, e o desejo de oferecer acolhimento e direcionamento adequado. Esse é, inclusive, um ponto interessante para as equipes explorarem na proposta: como comunicar acolhimento em um serviço novo, sem histórico de confiança já construído.

3. Histórico de Iniciativas (Lições Aprendidas)

3.1. Análise de Falhas: não há histórico de iniciativas anteriores da ACM voltadas a esse problema. O único precedente foi um evento promovido para discutir o tema, com a presença de profissionais de saúde que validaram a existência e a relevância dessa dor nos serviços de saúde de nosso ecossistema.

3.2. Cases de Sucesso: como benchmark, observamos que empresas de outros setores têm endereçado esse problema ampliando a disponibilidade de acesso à saúde mental para colaboradores por meio de plataformas como a Zenklub (Psicologia Viva), facilitando o acesso a profissionais de saúde mental. Esse modelo de ampliação de acesso facilitado pode ser um fator relevante a considerar.

4. Escopo Técnico da PoC

4.1. Para o hackathon, o foco deve contemplar o ciclo completo em profundidade: triagem (GAD-2/PHQ-2), direcionamento assertivo (para o canal certo, conforme risco e vínculo SUS/privado) e acompanhamento (follow-up). Não é necessário desenvolver os quatro formulários mencionados na documentação original — o critério de avaliação está na robustez desse fluxo de triagem → direcionamento → follow-up.

Qualquer dúvida adicional, fico à disposição.

Atenciosamente,
Marcello Alberton Herdt
Diretor de Inovação — ACM

Outros Esclarecimentos e Perguntas Reservadas

Enviar email para: HUDSONSILVA@ACM.ORG.BR

Com cópia para: PREINCUBADORA.FLN@IFSC.EDU.BR

Assunto: **Hackathon: Burnout Médico: A Dor de Quem Cuida dos Outros**

Dica: Envie inclusive as dúvidas reservadas que já foram encaminhadas, para receber respostas diretas